



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : زينب عيد امام ابو القمصان
المحافظة : القليوبية
الحى / المدينة : طوخ
رقم البطاقة : 29101131401582 رقم التليفون : 01284173977
العنوان : مشتهر
العمر (تاريخ الميلاد) : 13-01-1991 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 19-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي زولاديكس تحت الجلد لمدة 6 شهور
قسم العلاج :
الاورام

[14163]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. /----- /د. /----- /د. /----- /د. /-----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: زينب عيد امام ابو القمصان National ID: 29101131401582	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Goserelin (Zoladex) subcutaneous

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين


 جمهورية مصر العربية
 وزارة الداخلية
 ركن
 عبد امام ابو القمصان
 مقيم
 مركز طلوع - القليوبية
 ١٩٩١/٠١/١٣
 ٢٩١٠١١٣١٤٠١٥٨٢
 LE2722367


 ٢٠٢٥/٠٥
 ٢٩١٠١١٣١٤٠١٥٨٢
 ربة منزل
 أنثى
 متزوجة
 صبيحي عبد العال محمد علي زيدان
 البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠٥/١٨

 ١١



Patient Name	: الأستاذة / زينب عبد امام ابو القمصان	Request No.	: 13009471
Patient No.	: 29101131401582	Request Date	: 24/04/2022
Path No.	: 1131/22	Verification Date	: 18/05/2022
Sex	: Female	Financial Category	: نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age	: 31 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left Breast Cancer (Post Neo-Adjuvant chemotherapy)

Nature of the specimen: Left WLE & SLNB

Gross Examination:

- Procedure: WLE measured 10x5x3cm with skin ellipse measured 7x1.5cm. covering skin was grossly unremarkable. Serial sections revealed an ill-defined firm gritty greyish white mass, measured 2.5x2cm, located 0.1cm from least superior margin.
- Lymph nodes number and size: Three Nodules up to 1x0.5cm
- Extra-superior margin: A fibrofatty tissue piece, measured 4.5x3cm, showing a rubbery area measured 3x2cm, surrounded by fat free of residual tumour grossly.
- Frozen section: - Free (0/3) SLNs, Free All Margins

Microscopic examination:

- Histological type: Invasive Ductal Carcinoma
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): GII (3+2+1)
- Angioinvasion: No
- Ductal carcinoma in situ: Major 70%
- Tumor extent: Actual tumour surface area= 2 cm
- Skin involvement: Free
- Lymph node involvement: Free (0/3) SLNs
- Free resection margins showing fibrocystic changes
- Histologic response to therapy: Pathological Partial Response

Diagnosis:

Left Breast Cancer, Left WLE & SLNB:

- Invasive Ductal Carcinoma GII with 70% Ductal carcinoma in situ
- Free (0/3) SLNs

Verified by :

Dr.Marwa mahmoud

Printing Date : 18/05/2022 09:28:06

Page 1 of 2

Printing By : Ali mostafa

Patient Name : الأستاذة / زينب عيد امام ابو القمصان	Request No. : 13009471
Patient No. : 29101131401582	Request Date : 24/04/2022
Path No. : 1131/22	Verification Date : 18/05/2022
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - رام دار السلام
Age : 31 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : .marwa mohamed yc

Pathology Report

- Free Resection Margins showing fibrocystic changes
- Pathological Partial Response
- Stage: ypT2, ypN0
- RCB= 1.863, RCB class-II

Dr. Menna Atef

Prof. Lubna Omar

Verified by : 
Dr. Marwa mahmoud

Patient Name : الأستاذة / زينب عيد امام ابو القمصان
Patient No. : 29101131401582
Path No. : 2422/21
Sex : Female
Age : 30 Y
Referring Doctor:

Request No. : 130205
Request Date : 14/10/2021
Verification Date : 26/10/2021
Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Department : Out Patient
IHC No. :

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Left breast mass

• Nature of the specimen: Biopsy

Gross Examination: Four grayish white cores, up to 0.8 cm. Totally submitted.

• Procedure: Tru cut

• Localization: Left

• Immunohistochemistry technique: Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, HER2, ER clone (SP1), PR clone (1E2), HER-2 CLONE (4B5), & Ki67 (30-9)

Microscopic examination:

• Histological type: Invasive duct carcinoma

• Grade: G III

• Angiolysis: No

• Ductal carcinoma in situ: Yes

Diagnosis:

Left breast mass, Core biopsy;
Invasive duct carcinoma, grade III

• Biomarkers:

o ER: Moderate 20% nuclear reaction (Allred score 4/8)

o PR: Moderate 15% nuclear reaction (Allred score 3/8)

o Her2: No membrane reaction (score 0)

o Ki67: 18% nuclear reaction

Prof. Dr. Amal Hareedy
Dr. Mona Mohamed

Printing Date : 30/10/2021 11:51:18

Page 1 of 2

Printed By : .marwa mohamed yousef



Name : Zeinab eld Emam

Date : 4-11-2021

**POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST,
ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -**

***Known left breast cancer.**

1. Chest:

- Left breast UOQ irregular enhancing parenchymal mass is seen measuring 2.7x 2.2 cm.
- Solitary tiny pulmonary nodule is seen at the middle lobe measuring 4 mm.
- Otherwise, No sizable pulmonary masses, sizable nodules, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion.
- Normal cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. Abdomen and pelvis:

- The liver is of average size with homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- IUD is seen in place.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic lymphadenopathy or collections.
- No suspicious lytic or sclerotic bone lesions.

OPINION:

- Left breast UOQ irregular enhancing parenchymal mass lesion.
- Middle lobar, solitary tiny pulmonary nodule likely of benign nature. No definite metastatic pulmonary deposits.
- No hepatic focal lesions.
- No suspicious lytic or sclerotic bone lesions.

Dr. M. Gomaa, M.D.

Patient name: زينب: سيد امام

Date: 30/03/2022

Combined bilateral breast mammography and complementary ultrasound

Indication:

Known case of left breast cancer on therapy

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral 3D MLO DBT (Digital Breast tomosynthesis)
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- Left metallic clip seen within lesion.
- Right LIQ medium dense mass.

Complementary ultrasound :

- left UOQ partial response of irregular solid mass lesion measuring about 28 x18mm with highly internal; vascularity seen within compared to previous study as 34 x20mm.
- left small satellite seen at 3 o'clock measuring about 7 x4mm.
- left 10 o'clock well defined hypoechoic lesion measuring about 15 x7mm.
- Right 4 O'clock irregular hypoechoic solid mass , measured about 13 x7mm
- No cystic mass lesions.
- Normal right skin thickness. and nipple-areola complex with average caliber of the retro-areolar central ducts.
- Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Partial response of left UOQ pathologically proven carcinoma (BIRADS 6)
- Right benign looking lesion likely fibroadenoma (BIRADS n3)

Best regards,
Dr. Nehal Hamdey, FEBR, MSc



مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

الاستشارة
طبية
مصر

MDT FORM

26/5/2022

Name	د. عبد الله	MRN	0.01 / 1277
Age	31	ID	091.11214.1000
Menopausal status		Phone	1152152977
OCP		marital status	
Co morbidity		Family history	

Clinical Data

Bx:	3DC	HER 2:	Ki67:	R
ER:	PR:			
418	318		18%	
Sonomammography:				

CT2 No. mo	read NACT	TNM	REC X3 + TAT X3
Recommendations:			
→ WL6 + SLNB. (18/5/2022)			
→ 4PT2 - 4P No/3.			
2.5x2cm. pcrha & pathologic Resp'n			

MDT OUTCOME & PLAN

For Adjuvant H₂ etc.
TAM + Zoladex. → shifted to AI/Zoladex
+ PORT.

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY



Patient Name: Zainab Eid Emam Abu Al Komsan	Date : 14/12/2024
Exam : ultrasound ABDOMEN& PELVIS	Age : 34 Year(s)
Medical ID: 4668/2021	Pat. ID: 43224

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION
REVEALED:

Liver: -

- Average in size, smooth outline, homogenous echopattern.
No intra hepatic biliary radicle dilatation.
- Portal vein is not dilated and patent .

Gall Bladder: -

- Average size , normal wall thickness, no stones.
- CBD is not dilated.

Spleen: Average size, displaying homogenous echopattern.

Kidneys: -

- Are of normal size and site , normal echogenicity , with left sided cortical renal small simple cyst, measuring about 1x1cm, yet no stone or backpressure changes.

URINARY BLADDER: Normal filling. Normal wall thickness, no stones or diverticulae or solid lesion detected.

NB: Marked colonic distension which makes proper pelvic examination difficult.

Opinion:

- Left renal simple cortical cyst.
- Marked colonic gaseous distension.

Best Regards,
Dr. Nourhan Muhammed.



Patient Name: Zainab Eid Emam Abu Al Komsan	Date : 14/12/2024
Exam : Item 1	Age : 34 Year(s)
Medical ID:	Pat. ID: 43224

Plain X-ray **Chest** (PA view) revealed:,

- *Clear both lung fields.*
- *Clear both costo-phrenic angles.*
- *Normal cardiac size & configuration.*
- *Normal thoracic cage*

Yours truly,

DR. Nourhan Muhammed



Patient Name: Zainab Eid Emam Abu Al Komsan	Date : 14/12/2024
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 34 Year(s)
Medical ID: 4668/2021	Pat. ID: 43224

**BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION
ULTRASOUND**

Indication:

Patient had left CBS

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- The breasts are Scattered fibro glandular density (ACR B)
- No right breast suspicious mass lesions, micro calcifications or architectural distortion detected.
- Left breast UOQ focal area of parenchymal distortion owing to prior surgical interference, with post-operative scarring and diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- Complementary ultrasound showed left breast UOQ focal parenchyma distortion, owing to prior surgical interference with clear operative bed with no evidence of recurrent mass lesions.
- Right 4:00 ill-defined hypoechoic oval shaped solid lesion measuring 1.2x0.7 cm
- no right breast cystic mass lesions, normal skin thickness and nipple-areola complex.
- Nonspecific right axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free left infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Left breast focal parenchymal distortion owing to prior surgical interference (CBS) with post-operative sequel, with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions (BIRADS 2)
- Right 4:00 stationary benign looking solid lesion (BIRADS 2)

Yours truly

Signature Dr. Yasmin Nada

14/12/2024 1:26 PM